

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Peningkatan Peran Apoteker sebagai *Agent of change* dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggunaan Obat Tradisional

2. Tim Peneliti Pengusul (TPP) terdiri atas

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instanssi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Sri Suwarni, M.Sc., Apt.	Ketua	Manajemen Farmasi/ Farmasi Sosial	Akademi Farmasi Nusaputera	8 jam
2	Nurista Dida Ayuningtyas, M.Sc., Apt.	Anggota	Teknologi Farmasi	Akademi Farmasi Nusaputera	5 jam

3. Tim Peneliti Mitra (TPM) terdiri atas

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instanssi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Aris Widayati, M.Si., Ph. D., Apt.	Ketua	Farmasi Sosial	Universitas Sanata Dharma Yogyakarta	8 jam
2	Dr. Erna Tri Wulandari, M.Si., Apt.	Anggota	Farmasi Bahan Alam	Universitas Sanata Dharma Yogyakarta	5 jam

4. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian) :

Apoteker sebagai *agent of change* dengan kemampuan untuk pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kamandirian obat dengan

- penggunaan obat tradisional yang berperan mengimplementasikan hasil penelitian berupa Model Program hasil rumusan dari *Focused- Group Discussion* (FGD) Badan POM, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah.
5. Masa Pelaksanaan :
- Tahun I
- Mulai : bulan Januari tahun 2020
- Berakhir : bulan Desember tahun 2020
- Tahun II
- Mulai : bulan Januari tahun 2021
- Berakhir : bulan Desember tahun 2021
6. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang :
- Tahun ke-1 : Rp 100.000.000,-
 - Tahun ke 2 : Rp 100.000.000,-
7. Lokasi Penelitian : di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Papua dan Nusa Tenggara.
8. Instansi lain yang terlibat :
- a. Ikatan Apoteker Indonesia
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Badan POM
 - d. Tim Penggerak PKK
9. Temuan yang ditargetkan :
- Menggali persepsi apoteker terkait kesiapan menjalankan perannya sebagai *agent of change* dalam pemberdayaan masyarakat mengenai obat tradisional. Penelitian ini mempunyai urgensi untuk perumusan model program pemberdayaan masyarakat tentang penggunaan obat tradisional yang dapat dilakukan apoteker.
10. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu :
- Penelitian ini memberikan kontribusi pada bidang farmasi sosial, dimana dengan Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan profesional mempunyai tanggung jawab besar terkait dengan penggunaan obat tradisional, terutama apoteker di apotek/komunitas yang berhadapan langsung dengan konsumen, yaitu mulai dari pemilihan untuk penggunaan, memastikan keamanan penggunaan, dan memberikan edukasi tentang obat tradisional.

11. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi) :

Luaran dari penelitian ini adalah publikasi internasional pada journal Q1

Research in Social and Administrative Pharmacy dan pada jurnal nasional Sinta 2 (*green tick*) yaitu *Journal of Pharmaceutical Sciences and Community* (JPSC) / Jurnal Farmasi Sains dan Komunitas (JFSK). Ketua Tim Peneliti Mitra (TPM) mempunyai pengalaman publikasi artikel di jurnal tersebut, sehingga diharapkan akan mendukung tercapainya luaran penelitian ini

RINGKASAN

World Health Organization (WHO) mencatat prevalensi penggunaan obat tradisional di kalangan masyarakat dunia sebesar 65% -95% (1). Di Indonesia, gaya hidup *back to nature* menyebabkan kecenderungan penggunaan obat tradisional yang semakin meningkat (2). Kepercayaan masyarakat Indonesia dalam penggunaan jamu dan herbal asli Indonesia cukup tinggi (3). Sumber informasi tentang obat tradisional sangat penting bagi masyarakat dan dapat menentukan keputusan masyarakat dalam penggunaan obat tradisional. Sebagian besar masyarakat memperoleh informasi tentang obat tradisional biasanya dari teman atau anggota keluarga (4,5). Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan mempunyai tanggung jawab besar terkait dengan penggunaan obat tradisional, karena terdapat aspek keamanan penggunaan yang perlu diinformasikan (6,7). Pada aspek regulasi pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang “Pelayanan Kesehatan Tradisional” yang tertuang dalam PP No. 103 Tahun 2014. Dalam PP tersebut diamanatkan bahwa obat tradisional hendaknya dimanfaatkan secara bersinergi dengan obat konvensional di Fasilitas Layanan Kesehatan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu amanat dalam PP tersebut (8). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi persepsi apoteker mengenai kesiapannya berperan sebagai *agent of change* dalam pemberian informasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penggunaan obat tradisional; sehingga dapat dirumuskan model program pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan oleh apoteker terkait penggunaan obat tradisional.

Jenis penelitian ini adalah observasional dan dilakukan dalam dua tahun, dengan pendekatan kualitatif. Responden adalah apoteker yang berpraktik di lima pulau besar di Indonesia, yaitu di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, yang dipilih secara *non- random purposive* dengan mengutamakan tercapainya variasi sampel. Tahun pertama akan dilakukan wawancara terstruktur dengan panduan wawancara untuk mengungkap persepsi apoteker terhadap kesiapannya sebagai *agent of change* dalam memberikan informasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penggunaan obat tradisional. Jumlah sampel diambil 10 apoteker di tiap pulau besar tersebut, sehingga total jumlah responden adalah 50. Tahun kedua akan dilakukan *Focused Group Discussion* (FGD) dengan menggunakan panduan FGD yang disusun dari hasil dan temuan pada tahun

pertama. Peserta FGD adalah para *stakeholder*, yaitu dari organisasi profesi (Ikatan Apoteker Indonesia), BPOM, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah. Jumlah *stakeholder* yang akan diundang FGD ditentukan sejumlah maksimal 25 orang. Tujuan FGD adalah untuk merumuskan model program pemberdayaan masyarakat terkait penggunaan obat tradisional yang akan dilakukan oleh apoteker. Data kualitatif hasil wawancara dan FGD akan dianalisis secara tematik dengan bantuan *software NVivo*.

Kata kunci : Obat tradisional, peran apoteker, pemberdayaan masyarakat

DAFTAR ISI

RINGKASAN	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang	4
2. Tujuan	5
3. Manfaat	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
1. Regulasi dan Penggunaan Obat Tradisional di Indonesia	7
2. Pemberdayaan masyarakat terkait penggunaan obat tradisional.....	7
3. Peran apoteker dalam pemberdayaan masyarakat terkait penggunaan obat tradisional	8
4. Penelitian – penelitian tentang peran apoteker dalam upaya pemberdayaan masyarakat mengenai obat tradisional (<i>State of the Art</i>).....	9
BAB II.....	11
METODOLOGI PENELITIAN.....	11
1. Jenis dan desain penelitian (Dua tahun)	11
2. <i>Ethical Clearence</i> dan Ijin Penelitian.....	11
JADWAL	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Penggunaan obat tradisional sudah lazim di kalangan masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang. *World Health Organization* (WHO) mencatat prevalensi penggunaan obat tradisional di kalangan masyarakat sebesar 65% -95% (1). Misalnya, sebuah penelitian di Kuwait yang melaporkan penggunaan obat tradisional sebesar 71,4% (4) dan 90% di Mexico City (9). Di Indonesia, Survei Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menemukan 15% responden survei menyimpan obat tradisional di rumah untuk sehari – hari (10). Survei lain terhadap 559 responden juga menemukan 20% dari mereka menggunakan obat tradisional untuk pengobatan mandiri (11). Kepercayaan masyarakat Indonesia dalam penggunaan jamu dan herbal asli Indonesia juga cukup tinggi (3).

Keputusan penggunaan obat tradisional oleh masyarakat ditentukan salah satunya oleh sumber informasi yang diperoleh. Lazimnya informasi tentang obat tradisional diperoleh dari teman atau anggota keluarga (4,5). Sebuah penelitian di Kanada menyebutkan bahwa responden memperoleh informasi tentang obat tradisional dari berbagai sumber, namun bukan dari apoteker sebagai ahli di bidang obat - obatan. Sebagian responden penelitian tersebut juga berharap bahwa apoteker adalah profesi kesehatan yang dapat memberikan informasi dan saran profesional mengenai interaksi antara obat tradisional dan obat konvensional, serta mampu mengevaluasi dan merekomendasikan informasi yang paling dapat dipercaya mengenai penggunaan obat tradisional. Penelitian ini menunjukkan bahwa harapan dan perilaku konsumen secara signifikan mempengaruhi persepsi apoteker tentang tanggung jawab profesional mereka sehubungan dengan penggunaan obat tradisional (7).

Terkait dengan upaya pemanfaatan obat tradisional pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang “Pelayanan Kesehatan Tradisional” yang tertuang dalam PP No. 103 Tahun 2014. Dalam PP tersebut diamanatkan bahwa obat tradisional hendaknya dimanfaatkan secara bersinergi dengan obat konvensional di Fasilitas Layanan Kesehatan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu amanat dalam PP tersebut (8).

Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan profesional mempunyai tanggung jawab besar terkait dengan penggunaan obat tradisional, terutama apoteker di apotek/komunitas yang berhadapan langsung dengan konsumen, yaitu mulai dari pemilihan untuk penggunaan, memastikan keamanan penggunaan, dan memberikan edukasi tentang obat tradisional (6). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 diamanatkan bahwa apoteker menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian yang salah satunya adalah pelayanan kefarmasian meliputi pemberian informasi sediaan Farmasi yang dapat berupa obat, obat tradisional, dan kosmetika (12). Namun demikian belum banyak penelitian yang mengungkap kesiapan apoteker dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tentang penggunaan obat tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menggali persepsi apoteker terkait kesiapan menjalankan perannya sebagai *agent of change* dalam pemberdayaan masyarakat mengenai obat tradisional. Penelitian ini mempunyai urgensi untuk perumusan model program pemberdayaan masyarakat tentang penggunaan obat tradisional yang dapat dilakukan apoteker.

Penelitian ini diajukan untuk skema Penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi (PKPT) dengan Tim Peneliti Mitra (TPM) dari Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma (USD). Sebagai institusi Fakultas Farmasi USD adalah salah satu institusi pendidikan tinggi Farmasi terkemuka di Indonesia. Ketua peneliti TPM (Aris Widayati, M.Si., Apt., PhD) mempunyai pengalaman yang cukup dalam hal publikasi di jurnal internasional bereputasi, dengan Scopus h- index: 4 dan Goggle h-index: 7, dengan jumlah artikel yang terindeks Scopus sebanyak 7 artikel pada jurnal Q1, Q2, dan Q3. Dengan pengalaman tersebut maka luaran wajib penelitian ini akan tercapai di bawah bimbingan TPM.

b. Tujuan

Mengeksplorasi persepsi apoteker mengenai kesiapannya berperan sebagai *agent of change* dalam pemberian informasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penggunaan obat tradisional; sehingga dapat dirumuskan model program pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan oleh apoteker terkait penggunaan obat tradisional

c. Manfaat

Sebagai rumusan model program pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan oleh apoteker terkait penggunaan obat tradisional berkaitan dengan pengembangan dan Penguatan Sistem dalam Organisasi Apoteker memberikan masukan pada kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kamandirian obat dengan pemanfaatan pengetahuan Lokal untuk penggunaan jamu dan herbal dalam kesehatan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Regulasi dan Penggunaan Obat Tradisional di Indonesia

Dalam upaya pemanfaatan obat tradisional pemerintah Indonesia melalui PP No. 103 Tahun 2014 tentang “Pelayanan Kesehatan Tradisional” mengamanatkan bahwa obat tradisional hendaknya dimanfaatkan secara bersinergi dengan obat konvensional di Fasilitas Layanan Kesehatan Masyarakat. Menurut Permenkes RI Nomor 007 Tahun 2012 definisi obat tradisional adalah “bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat”. Kementerian Kesehatan melalui penancangan pengembangan dan promosi obat tradisional telah mendorong dan menggalakkan kembali pemanfaatan obat tradisional Indonesia oleh masyarakat serta dikembangkan dalam dunia kedokteran (13).

Masyarakat mencari pengobatan tradisional dengan alasan tidak ada efek samping dan merasakan khasiatnya. Sumber informasi pribadi seperti keluarga, teman, tetangga dan kenalan merupakan informasi utama dalam membeli jamu. Masyarakat merasa puas setelah menggunakan jamu dan mempunyai loyalitas cukup tinggi terhadap jamu (14). Sebuah studi mengungkap bahwa keputusan masyarakat dalam memilih obat tradisional dipengaruhi oleh sumber informasi yang diperoleh, tingkat pendapatan, dan kepercayaan (15). Penerimaan penggunaan jamu sebagai alternatif penggunaan obat modern pada masyarakat ekonomi rendah-menengah dan atas secara umum tinggi, sebagian besar masyarakat masih mengkonsumsi jamu untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit di era modernisasi ini (3).

2. Pemberdayaan masyarakat terkait penggunaan obat tradisional

Upaya meningkatkan efektivitas partisipasi dalam proses pembangunan memerlukan pelibatan (inklusi) semua pihak. Untuk itu dibutuhkan adanya sumber dan saluran untuk memperoleh informasi yang beragam, mekanisme umpan balik, dan forum terbuka yang memungkinkan terjadinya proses pertukaran informasi, perencanaan dan pembahasan

program pembangunan secara bersama-sama dengan masyarakat (16). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional telah mengamanatkan pelibatan masyarakat dalam penggunaan obat tradisional untuk pelayanan kesehatan (8). Pemberdayaan dengan sasaran masyarakat atau komunitas merupakan sasaran utama kegiatan promosi kesehatan. Masyarakat sebagai sasaran primer promosi kesehatan diberdayakan agar mereka mau dan mampu memelihara kesehatannya (17).

3. Peran apoteker dalam pemberdayaan masyarakat terkait penggunaan obat tradisional

Sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker adalah tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian, salah satunya adalah pemberian informasi tentang sediaan Farmasi. Sediaan farmasi yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut meliputi obat, obat tradisional, dan kosmetika (12). Tanggungjawab apoteker dalam penyelenggaraan praktik kefarmasian termasuk upaya – upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik bagi perorangan, kelompok dan atau masyarakat. Tanggungjawab tersebut dikuatkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, baik di Rumah Sakit, apotek, maupun Puskesmas (18).

Konsep pelayanan kefarmasian dibutuhkan dan diterima pasien untuk menjamin keamanan dan penggunaan obat, termasuk obat tradisional yang rasional, baik sebelum, selama, maupun sesudah penggunaan obat termasuk obat tradisional. Oleh karena itu, seorang apoteker harus memiliki kompetensi dalam praktik kefarmasian yang diperoleh dari pendidikan formal, memiliki pengetahuan secara mendalam tentang jamu, memiliki pengetahuan dan keterampilan mengelola jamu serta memiliki tanggung-gugat profesi apoteker pada masyarakat khususnya pemanfaatan jamu. Kompetensi tersebut harus didukung dengan pengetahuan yang komprehensif mengenai obat tradisional, misalnya: Pengenalan tanaman obat, Formula jamu yang terstandar, Pengelolaan jamu (pengendalian mutu sediaan jamu, pengadaan, penyimpanan dan pengamanan jamu), Fitoterapi, Dosis dan monitoring evaluasi bahan aktif jamu, MESOT (Monitoring efek samping obat tradisional (19).

Lebih lanjut, dikeluarkannya Kepmenkes nomor 1076 tahun 2003 maka banyak dokter membuka praktek herbal (20). Hal ini memberi peluang sekaligus tantangan besar bagi profesi apoteker untuk berperan dalam pemberian informasi tentang obat tradisional, baik kepada pasien secara perseorangan maupun kepada masyarakat luas melalui kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

4. Penelitian – penelitian tentang peran apoteker dalam upaya pemberdayaan masyarakat mengenai obat tradisional (*State of the Art*).

Penelitian – penelitian tentang peran apoteker dalam pemberian informasi obat telah banyak dilakukan, namun hampir semuanya berfokus pada pemberian informasi obat dan edukasi mengenai obat konvensional, tidak banyak yang berfokus pada obat tradisional. Namun demikian, pada kenyataannya telah banyak pula kegiatan – kegiatan edukasi yang dilakukan oleh apoteker kepada masyarakat luas dalam bentuk penyuluhan yang mengangkat tema obat tradisional, hanya saja kegiatan – kegiatan tersebut biasa bersifat sporadis dan atas inisiatif apoteker sendiri atau berafiliasi dengan institusi karena tuntutan kinerja. Misalnya, kegiatan pengabdian berupa edukasi kepada masyarakat yang mengangkat tema TOGA (Tanaman Obat Keluarga) yang pelaksanaannya adalah seorang apoteker (21).

Evaluasi terhadap implementasi peraturan- peraturan tentang pengobatan tradisional, seperti Kepmenkes nomor 1076 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional dan Permenkes 1109 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif telah dilakukan di tiga Provinsi yaitu Bali, Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada tahun 2011. Evaluasi ini melibatkan para *stakeholder* penyelenggara pengobatan dan organisasi profesi kesehatan terkait. Hasil penelitian mengungkap adanya beberapa hambatan dalam penyelenggaraan pengobatan tradisional, terutama masalah regulasi di daerah, rumusan kompetensi yang mendukung, dan belum adanya kolegium yang dapat memberikan rekomendasi bagi dokter untuk berpraktek dengan pengobatan tradisional (20).

Pemerintah pusat telah mendukung penggunaan obat tradisional dengan regulasi – regulasi tentang pelayanan kesehatan tradisional. Riset – riset menuju ke saintifikasi jamu juga menjadi prioritas riset nasional untuk menghasilkan produk fitofarmaka yang telah

melalui uji klinis pada manusia, sehingga penggunaan obat tradisional didukung dengan bukti ilmiah (*evidence-based*). Oleh karena itu, apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan harus mengambil peran aktif dalam proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, dalam hal ini dapat sebagai *agent of change* di masyarakat melalui program – program pemberdayaan masyarakat. Celah (*State of the art*) inilah yang akan diisi oleh penelitian yang diusulkan ini. *Roadmap* pengembangan pemberdayaan masyarakat mengenai obat tradisional melalui peran apoteker sebagai *agent of change* dapat dilihat pada bagan berikut.

d. *Roadmap* Penelitian



Gambar 1. *Roadmap* pengembangan pemberdayaan masyarakat mengenai obat tradisional melalui peran apoteker sebagai *agent of change*

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan desain penelitian (Dua tahun)

Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan studi kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun. Sampel penelitian adalah apoteker yang dipilih di lima pulau besar di Indonesia, yaitu: Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

i). Tahun pertama

Data dikumpulkan dengan teknik wawancara terstruktur. Jumlah sampel tahun pertama ditentukan dengan sampling kuota sebanyak 78 orang yang dipilih secara *purposive* dari lima wilayah pulau besar tersebut dengan mempertimbangkan variasi karakteristik sampel sebanyak mungkin. Instrumen penelitian adalah panduan wawancara untuk mengeksplorasi persepsi mengenai. Kesiapan apoteker sebagai *agent of change* dalam program pemberdayaan masyarakat mengenai penggunaan obat tradisional. Data hasil wawancara akan ditranskrip secara verbatim dan diolah dengan metode *thematic analysis* dengan bantuan *software NVivo*.

ii). Tahun kedua

Sampel tahun kedua dipilih dengan teknik *purposive sampling* sebanyak 25 *key decision maker* yaitu *stakeholder* dari organisasi profesi apoteker (Ikatan Apoteker Indonesia), Badan POM, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah. Data dikumpulkan dengan teknik *Focused- Group Discussion* (FGD) dengan untuk merumuskan model program peran apoteker dalam pemberdayaan masyarakat terkait penggunaan obat tradisional. Panduan FGD dibuat mengacu pada hasil penelitian tahun pertama. Data diolah secara tematik dengan bantuan *software NVivo*.

2. Ethical Clearence dan Ijin Penelitian

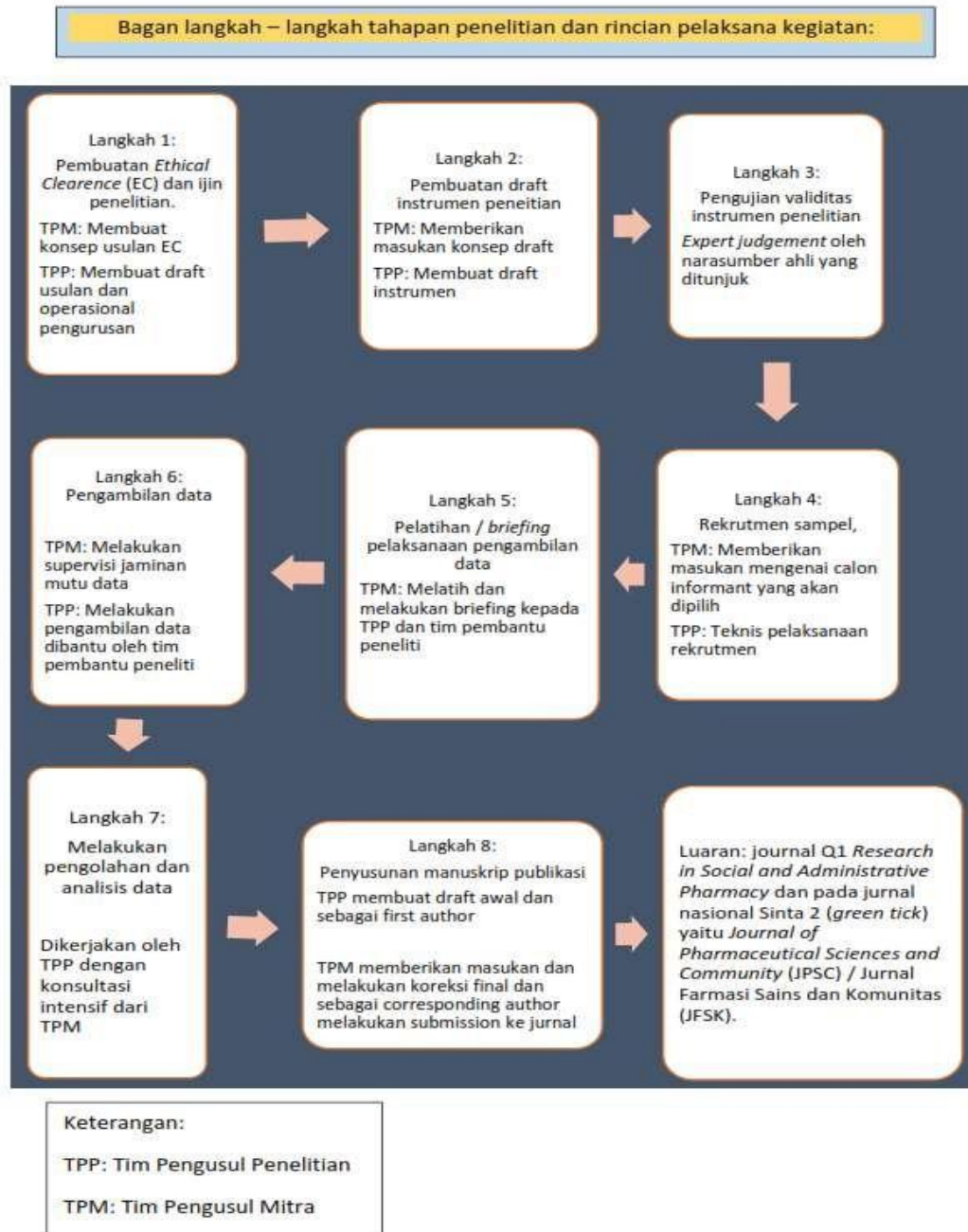
Ethical Clearence akan diajukan ke Komite Etik Penelitian. Ijin penelitian akan diajukan kepada dinas perijinan setempat. Kaidah etika penelitian akan dipenuhi dengan memastikan keikutsertaan responden secara sukarela dengan menandatangani *informed*

consent setelah diberikan penjelasan singkat tentang penelitian. Semua data diri responden akan dijamin kerahasiaannya dalam dokumen publikasi apapun.

3. Alur tahapan penelitian, peran tim peneliti, dan ketercapain indikator luaran penelitian (multi - tahun)

Langkah – langkah tahapan penelitian adalah sebagai berikut: 1) pengurusan *Ethical Clearence* dan perijinan penelitian; 2) penyusunan *draft* instrumen penelitian; 3) uji validitas instrumen penelitian; 4) rekrutmen sampel / *key informant*; 5) pelatihan / *briefing* mengenai pelaksanaan pengambilan data; 6) pengambilan data; 7) pengolahan dan analisis data; 8) penyusunan *draft* manuskrip publikasi. Alur tahapan penelitian, peran tim peneliti, dan ketercapain indikator luaran penelitian dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 2. Langkah Tahapan Penelitian



JADWAL

Tahun ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengajuan <i>Ethical Clearence</i>	v											
2	Training untuk <i>Data Collectors</i>		v										
3	<i>Drafting</i> dan Uji Coba Instrumen	v	v										
4	Proses sampling			v									
5	Pengumpulan Data				v	v	v						
6	Pengolahan dan analisis data					v	v	v					
7	Draft naskah publikasi						v	v	v				
8	Submit dan revisi naskah publikasi									v	v	v	v

Tahun ke-2

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengajuan <i>Ethical Clearence</i>	v											
2	Training untuk <i>Data Collectors</i>		v										
3	<i>Drafting</i> dan Uji Coba Instrumen	v	v										
4	Proses sampling			v									
5	Pengumpulan Data				v	v	v						
6	Pengolahan dan analisis data					v	v	v					
7	Draft naskah publikasi						v	v	v				
8	Submit dan revisi naskah publikasi									v	v	v	v

DAFTAR PUSTAKA

1. WHO. *Traditional, Complimentary and Integrative Medicines* [Internet]. [cited 2019 Aug 10].
Available from: <https://www.who.int/traditional-complementary-integrative-medicine/about/en/>
2. Tilaar M, Wih WL, Ranti AS. *The Green Science of Jamu*. Jakarta: Dian Rakyat; 2010. 202 p.
3. Andriati A, Wahjudi RMT. 2016, Tingkat penerimaan penggunaan jamu sebagai alternatif penggunaan obat modern pada masyarakat ekonomi rendah-menengah dan atas. *Masyarakat, Kebud dan Polit*. 2016;
4. Awad A, Al-Shaye D. Public awareness, patterns of use and attitudes toward natural healthproducts in Kuwait: A cross-sectional survey. *BMC Complement Altern Med*. 2014;
5. Farooqui M, Hassali MA, Shatar AKA, Farooqui MA, Saleem F, Haq N ul, et al. Use of complementary and alternative medicines among Malaysian cancer patients: A descriptive study. *J Tradit Complement Med*. 2016;
6. Ung COL, Harnett J, Hu H. Community pharmacist's responsibilities with regards to traditional medicine/complementary medicine products: A systematic literature review. *Research in Social and Administrative Pharmacy*. 2017.
7. Kwan D, Boon HS, Hirschhorn K, Welsh S, Jurgens T, Eccott L, et al. Exploring consumer and pharmacist views on the professional role of the pharmacist with respect to natural health products: A study of focus groups. *BMC Complement Altern Med*. 2008;
8. Peraturan Pemerintah RI. *Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional*. 2014 p. 1–39.
9. Zeilmann CA, Dole EJ, Skipper BJ, McCabe M, Low Dog TL, Rhyne RL. Use of herbal medicine by elderly Hispanic and non-Hispanic white patients. *Pharmacotherapy*. 2003;
10. National Institute for Health Research & Development. *Riset Kesehatan Dasar (National Health Survey)*. Minist Heal Repub Indones. 2013;(1):1–303.
11. Widayati A. Health Seeking Behavior di Kalangan Masyarakat Urban di Kota Yogyakarta. *J Farm Sains dan Komunitas*. 2012;

12. Pemerintah RI. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*. 2009.
13. Kemenkes RI. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Formularium Obat Herbal Asli Indonesia*. 2016.
14. Maryani H, Kristiana L, Lestari W. Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Jamu Saintifik. *Bul Penelit Sist Kesehat*. 2017;
15. Ismail. Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Memilih Obat Tradisional Di Gampong Lam Ujong. *Idea Nurs J*. 2015;VI(1):7–14.
16. Umamur RD. Peta Inklusi Sosial Dalam Regulasi Desa. *REFORMASI*. 2017;7(2).
17. Rodiah, Lusiana, Agustine. Pemberdayaan Kader PKK dalam Usaha Penyebarluasan Informasi Kesehatan Jatinangor. *J Apl Ipteks untuk Masy*. 2016;
18. KemenKes R. *PMK RI No. 30/2014 Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk*. PMK RI. 2014;53(9):103.
19. Suharmiati S, Handayani L, Bahfen F, Djuharto D, Kristiana L. Kajian Hukum Peran “Apoteker” Dalam Saintifikasi Jamu. *Bul Peneliti Sistem Kesehatan*. 2012;15(1).
20. Herman MJ, Supardi S, Handayani RS. Policy On Herbal Traditional Medicines Therapy In Three Provinces In Indonesia. *Bul Penelit Kesehat*. 2013;
21. Widayati A, Wulandari ET. Edukasi Manfaat Tanaman Obat dan Pengolahannya dengan Metode CBIA di Desa Bulusulur , Kabupaten Wonogiri , Jawa Tengah. *Abdimas Altruus J Pengabd Kpd Masy*. 2018;1(1):25–30..

Bidang Fokus Riset	: Kesehatan – Obat
Tema Riset	: Pengembangan dan Penguatan Sistem Kelembagaan, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kamandirian obat
Topik Riset	: Pengetahuan Lokal untuk penggunaan jamu dan herbal

USULAN

PANDUAN WAWANCARA MENDALAM

HIBAH PENELITIAN PKPT (KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI)

TIM PENELITI PENGUSUL (TPP) : AKADEMI FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG
TIM PENELITI MITRA (TPM): UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA



Tim Peneliti Pengusul (TPP)

Sri Suwarni, M.Sc., Apt.

(Ketua)

NIDN : 0602097801

Nurista Dida Ayuningtyas, M.Sc., Apt.

(Anggota)

NIDN : 0619118601

Tim Peneliti Mitra (TPM)

Aris Widayati, M.Si., Ph. D., Apt.

(Ketua)

NIDN : 0530077401

Dr. Erna Tri Wulandari, M.Si., Apt.

(Anggota)

NIDN : 0527057101

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2019 - 2020

PANDUAN WAWANCARA MENDALAM

Penelitian Berjudul

PENINGKATAN PERAN APOTEKER SEBAGAI *AGENT OF CHANGE* UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL

Data Responden

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Tahun Lulus Apoteker :
5. Tempat praktek apoteker :
6. Alamat praktek apoteker :
7. Asal PC/PD IAI :
8. No.Kontak yang dapat dihubungi :
9. Alamat Email :

No	Pertanyaan utama	Pertanyaan Probing
1	Pertanyaan umum tentang topik yang diteliti: 1. Bagaimana pendapat Anda mengenai penggunaan obat tradisional di kalangan masyarakat Indonesia? 2. Bagaimana pendapat Anda mengenai peran apoteker dalam penggunaan obat tradisional di kalangan masyarakat Indonesia?	a. Knowledge Apakah Apoteker mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memberikan informasi serta memahami macam-macam Obat tradisional, cara penggunaan dan dosis yang digunakan untuk dimanfaatkan dalam terapi penyakit pasien secara swamedikasi dibawah pengawasan Apoteker. b. Expectations Apakah kemampuan Apoteker dalam KIE dapat diandalkan seperti pada saat Pasien berkonsultasi dengan Profesi kesehatan lainnya.
2	Pertanyaan tentang Kapabilitas apoteker sebagai AoC untuk pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat tradisional : a. Bagaimana pendapat Anda mengenai kemampuan apoteker Indonesia saat ini sebagai AoC? b. Bagaimana pendapat Anda mengenai kemampuan apoteker Indonesia jika harus berperan sebagai AoC dalam pemberdayaan masyarakat untuk penggunaan obat tradisional?	a. Strengths Apakah Profesi Apoteker mempunyai Basic kemampuan untuk memberdayakan masyarakat dalam penggunaan obat tradisional. Secara kemampuan dan legal Formal b. Weaknesses Apakah Apoteker mempunyai kemampuan dan sarana prasarana untuk secara persuasive dan motivatif sehingga dapat memberdayakan masyarakat dalam penggunaan obat tradisional. Apakah Masyarakat mempunyai kepercayaan pada Profesi Apoteker untuk memberdayakan masyarakat dalam penggunaan obat tradisional.
3	Pertanyaan tentang Peluang apoteker sebagai AoC dalam pemberdayaan masyarakat untuk penggunaan obat tradisional: Bagaimana pendapat Anda mengenai peluang apoteker sebagai AoC dalam pemberdayaan masyarakat untuk penggunaan obat tradisional?	a. Challenges Peluang dalam hal kemampuan, kesempatan legal formal Permenkes No 6 tahun 2016 tentang Formularium Obat Herbal Asli Indonesia membuka peluang untuk pemanfaatan Obat Asli Indonesia. b. Barrier Tetapi dalam Permenkes No 6 tahun 2016 tentang Formularium Obat Herbal Asli Indonesia tidak menyebutkan bahwa peluang untuk pemanfaatan Obat Asli Indonesia bukan hanya milik apoteker.
4	Pertanyaan tentang Motivasi apoteker sebagai AoC dalam pemberdayaan masyarakat untuk penggunaan obat tradisional: a. Seperti apa motivasi Anda jika harus berperan sebagai AoC dalam pemberdayaan masyarakat untuk penggunaan obat tradisional?	a. Beliefe Apakah Apoteker mempunyai performa dan kepercayaan diri memberikan KIE untuk memanfaatkan obat tradisional dalam terapi penyakit pasien secara swamedikasi dibawah pengawasan Apoteker. b. Attitudes Apakah Apoteker mempunyai sikap dan karakter yang memadai unruk memberikan konseling untuk memanfaatkan obat tradisional dalam terapi penyakit pasien secara swamedikasi dibawah pengawasan Apoteker.
5	Pertanyaan tentang Tindakan apoteker sebagai AoC dalam	a. Experiences Apakah Apoteker mempunyai pengalaman yang

	pemberdayaan masyarakat untuk penggunaan obat tradisional: 1. Seperti apa pengalaman Anda dalam berperan sebagai AoC? 2. Jika Anda pernah berperan sebagai AoC terkait dengan penggunaan obat tradisional, seperti apakah pengalaman Anda tersebut? 3. Bagaimana harapan Anda mengenai peran apoteker sebagai AoC dalam pemberdayaan masyarakat untuk penggunaan obat tradisional?	cukup untuk memberikan edukasi untuk memanfaatkan obat tradisional dalam terapi penyakit pasien secara swamedikasi dibawah pengawasan Apoteker. b. <i>Expectations</i> Apakah Apoteker mempunyai visi kedepan dan harapan mengenai peran apoteker sebagai AoC dalam pemberdayaan masyarakat untuk penggunaan obat tradisional
--	---	---

FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN
(FORMULIR *INFORMED CONSENT*)

Peneliti Utama		: Sri Suwarni,M.Sc.,Apt.	
Pemberi informasi		: Apoteker aktif dalam pelayanan kefarmasian	
Nama Subyek			
Tanggal Lahir (Umur)			
Jenis Kelamin			
Alamat			
No. Telp (HP)			
Daerah asal			
Pekerjaan pelayanan			
	JENIS INFORMASI	ISI INFORMASI (diisi dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat awam)	Setujui (Centang)
1	Judul Penelitian	Peningkatan Peran Apoteker sebagai <i>Agent of change</i> dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggunaan Obat Tradisional	
2	Tujuan Penelitian	Menggali persepsi apoteker terkait kesiapan menjalankan perannya sebagai <i>agent of change</i> dalam pemberdayaan masyarakat mengenai obat tradisional. Penelitian ini mempunyai urgensi untuk perumusan model program pemberdayaan masyarakat tentang penggunaan obat tradisional yang dapat dilakukan apoteker.	
3	Cara dan Prosedur Penelitian	Wawancara dan Implementasi Program baru	
4	Jumlah subyek	50 Apoteker	
5	Waktu Penelitian	2 tahun	
6	Manfaat Penelitian termasuk	Sebagai rumusan model	21

	manfaat bagi subyek penelitian	program pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan oleh apoteker terkait penggunaan obat tradisional berkaitan dengan pengembangan dan Penguatan Sistem dalam Organisasi Apoteker memberikan masukan pada kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kamandirian obat dengan pemanfaatan pengetahuan Lokal untuk penggunaan jamu dan herbal dalam kesehatan masyarakat.	
7	Risiko dalam penelitian	-	
8	Ketidaknyamanan subyek penelitian	Implementasi program baru dalam masyarakat	
9	Kompensasi bila terjadi resiko besar	Diselesaikan secara kekeluargaan difasilitasi Organisasi Profesi IAI	
10	Alternatif Penanganan (bila ada)	Penjaminan nama baik dan Kompensasi Vakasi ke Apoteker Rp 2.000.000,00 untuk kurun waktu penelitian.	
11	Instrumen dan perlakuan	Wawancara mendalam dan Implementasi program Peningkatan Peran Apoteker sebagai <i>Agent of change</i> dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggunaan Obat Tradisional	

Demikian data ini diisi untuk digunakan sebaik mungkin dengan tujuan penelitian dan tidak untuk disalahgunakan.

Responden

(Nama Lengkap)